

1. L'élévation de la pression artérielle est dite "essentielle" en présence de causes secondaires identifiables telles qu'une pathologie rénale, un désordre endocrinien ou une anomalie vasculaire.	1. Faux
2. L'hypertension artérielle est essentielle chez 95 % des patients hypertendus.	2. Vrai
3. La pression artérielle est distribuée selon une gaussienne dans la population.	3. Vrai
4. La résistance vasculaire dépend du diamètre des artères distales supérieur à 1mm.	4. Faux
5. L'activation orthosympathique est généralement présente chez les sujets hypertendus de plus de 40 ans.	5. Faux
6. Les effets de l'angiotensine II dans l'hypertension sont exclusivement médiés par les récepteurs AT1.	6. Faux
7. Les antagonistes de l'angiotensine II sont contre-indiqués si le patient a une insuffisance rénale aiguë.	7. Vrai
8. L'HTA rénovasculaire est la cause la plus fréquente d'HTA secondaire.	8. Vrai
9. La sténose athéroscléreuse des artères rénales est plus fréquente chez les femmes de moins de 50 ans.	9. Faux
10. La dysplasie fibromusculaire est plus fréquente chez les femmes de moins de 50 ans.	10. Vrai
11. La dilatation percutanée est bénéfique dans le traitement de la sténose athéroscléreuse des artères rénales.	11. Faux
12. Les diurétiques sont à éviter en cas de décompensation cardiaque.	12. Faux

13. Les bêta-bloquants à haute dose sont contre-indiqués chez les patients présentant une insuffisance cardiaque.	13. Vrai
14. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les sartans sont contre-indiqués chez les femmes enceintes.	14. Vrai
15. L'HTA systolique isolée est rare après l'âge de 60 ans.	15. Faux
16. Les antagonistes de l'angiotensine II et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont contre-indiqués chez les patients présentant une sténose bilatérale des artères rénales.	16. Vrai
17. La réduction de la consommation de sel peut être aussi efficace qu'un médicament antihypertenseur.	17. Vrai
18. Les récepteurs AT2 à l'angiotensine II ont une action pro-mitotique qui favorise l'hypertrophie cellulaire vasculaire et cardiaque.	18. Faux
19. L'HTA est généralement associée à des facteurs de risque cardiovasculaire tels que le tabagisme et le diabète.	19. Vrai
20. L'HTA est la cause la plus fréquente de consultation médicale.	20. Vrai
21. Le traitement pharmacologique de l'HTA doit être initié immédiatement après le diagnostic, quel que soit le risque cardiovasculaire.	21. Faux
22. L'HTA est généralement asymptomatique.	22. Vrai
23. Une réduction de 10 mmHg de la PAS et de 5 mmHg de la PAD diminue les événements coronaires de 35% et les accidents vasculaires cérébraux de 15% après quelques années de traitement.	23. Faux

24. Les médicaments à action centrale sont utilisés en première intention dans le traitement de l'HTA.	24. Faux
25. L'HTA maligne peut se compliquer d'une encéphalopathie hypertensive.	25. Vrai
26. L'HTA maligne est rarement compliquée par une insuffisance rénale aiguë.	26. Faux
27. Le traitement de l'HTA maligne doit être administré en urgence en ambulatoire.	27. Faux
28. L'œdème rétinien est une manifestation courante de l'HTA maligne.	28. Vrai
29. Les diurétiques sont à éviter chez le patient diabétique.	29. Vrai
30. L'HTA maligne est une HTA de grade 2 (>160-90) associée à une rétinopathie de stade III ou IV.	30. Faux
31. Le traitement pharmacologique de l'HTA doit être ajusté en fonction du risque cardiovasculaire.	31. Vrai
32. Une réduction de 10 mmHg de la PAS et de 5 mmHg de la PAD diminue les événements coronaires de 15 %.	32. Vrai
33. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont associés aux antagonistes de l'angiotensine II uniquement en cas d'HTA sévère (grade 3).	33. Faux
34. L'HTA diastolique isolée est plus fréquente après l'âge de 60 ans.	34. Faux
35. Une réduction de 10 mmHg de la PAS et de 5 mmHg de la PAD diminue les AVC de 25 %.	35. Faux
36. Le traitement pharmacologique de l'HTA est toujours nécessaire même si les mesures non pharmacologiques sont efficaces.	36. Faux

37. L'HTA maligne est souvent associée à une insuffisance cardiaque.	37. Vrai
38. L'HTA rénovasculaire représente environ 10% des cas d'HTA.	38. Faux
39. L'HTA est une affection généralement unifactorielle.	39. Faux
40. La tension artérielle est déterminé par le produit du débit cardiaque et de la résistance vasculaire périphérique.	40. Vrai
41. Le débit cardiaque dépend uniquement de la contractilité myocardique et de la fréquence cardiaque.	41. Faux
42. La résistance vasculaire dépend de la viscosité sanguine.	42. Vrai
43. L'angiotensine II est un agent antiprolifératif qui réduit l'hyperplasie cellulaire vasculaire et cardiaque.	43. Faux
44. La précharge est déterminée par la volume intra-vasculaire, le tonus veineux et la capacitance des vaisseaux.	44. Vrai
45. L'activation orthosympathique augmente à la fois le débit cardiaque et les résistances périphériques.	45. Vrai
46. Les taux de rénine plasmatique sont généralement élevés chez les patients hypertendus.	46. Faux
47. L'angiotensine II stimule la vasodilatation, la réabsorption de sodium, la soif et l'activité orthosympathique.	47. Faux
48. Les récepteurs AT2 à l'angiotensine ont une action antiproliférative et antimitotique favorable dans l'HTA.	48. Vrai
49. Le régime riche en sodium et riche en potassium favorise l'hypertension artérielle.	49. Faux
50. L'alcool n'a aucun effet sur la pression artérielle.	50. Faux
51. La stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone diminue la réabsorption du sodium.	51. Faux

52. L'hypertrophie des cellules musculaires de la média est favorisée par l'activation orthosympathique.	52. Vrai
53. L'hypertension artérielle a une composante génétique.	53. Vrai
54. La sécrétion de rénine est stimulée par l'ischémie rénale.	54. Vrai
55. 10% de la variabilité des chiffres tensionnels est déterminée génétiquement, le reste dépend de facteurs environnementaux.	55. Faux
56. L'HTA touche 50% des adultes et 70% des patients de plus de 70 ans.	56. Faux
57. La pression diastolique a tendance à diminuer avec l'âge.	57. Vrai
58. Les œdèmes pulmonaires subits peuvent être la manifestation d'une HTA rénovasculaire.	58. Vrai
59. Les lésions sont généralement distales en cas de dysplasie fibromusculaire et proximales en cas de sténose athéroscléreuse des artères rénales.	59. Vrai
60. La correction de la sténose des artères rénales n'améliore pas vraiment la pression artérielle.	60. Vrai
61. La sténose des artères rénales diminue la perfusion des reins et active le SRAA.	61. Vrai
62. La dysplasie fibromusculaire touche le plus souvent les 2 artères rénales.	62. Faux
63. La correction de la sténose peut normaliser la pression artérielle en cas de dysplasie fibromusculaire mais pas en cas de sténose athéroscléreuse des artères rénales.	63. Vrai

64. L'activation du système rénine-angiotensine peut être causée par une dysplasie fibromusculaire chez les femmes de moins de 50 ans.	64. Vrai
65. Les reins présentent des lésions dans la majorité des cas de dysplasie fibromusculaire.	65. Faux
66. La présence d'une sténose bilatérale des artères rénales peut aggraver la fonction rénale lors du traitement par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des sartans.	66. Vrai
67. Il faut penser à une HTA rénovasculaire devant une HTA récente, sévère, qui s'aggrave ou qui résiste à une bithérapie hypotensive dont un diurétique.	67. Faux
68. Les hommes de plus de 50 ans sont plus susceptibles d'avoir une sténose athéroscléreuse que les femmes du même groupe d'âge.	68. Vrai
69. Le dépistage de l'HTA rénovasculaire peut être effectué par échographie rénale et doppler des artères rénales.	69. Vrai
70. Les meilleurs tests de diagnostic pour l'HTA rénovasculaire sont l'angiographie par CT-scanner et ou par résonance magnétique nucléaire.	70. Vrai
71. La dilatation percutanée est bénéfique pour les patients atteints de dysplasie fibromusculaire.	71. Vrai
72. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont souvent très efficaces pour réduire la pression artérielle chez les patients atteints de sténose athéroscléreuse.	72. Vrai

73. Les AINS sont recommandés dans le traitement de la sténose athéroscléreuse.	73. Faux
74. L'angiographie par résonance magnétique nucléaire est un meilleur test diagnostique que l'échographie mais expose le patient à des radiations ionisantes.	74. Faux
75. La majorité des cas de sténose athéroscléreuse des artères rénales progressent vers une insuffisance rénale terminale.	75. Faux
76. La sténose athéroscléreuse des artères rénales est souvent associée à des lésions rénales.	76. Vrai
77. L'HTA touche environ 25 % des adultes.	77. Vrai
78. Les accidents vasculaires cérébraux sont la principale cause de décès liée à l'hypertension.	78. Faux
79. La définition de l'HTA est basée sur des critères stricts et non arbitraires.	79. Faux
80. L'HTA de grade 2 se caractérise par une PAS de 140-159 mmHg et une PAD de 90-99 mmHg.	80. Faux
81. L'hypertension systolique isolée est fréquente chez les personnes de moins de 60 ans.	81. Faux
82. Seuls 70 % des patients hypertendus sont diagnostiqués.	82. Vrai
83. La majorité des hypertendus sont contrôlés avec un traitement médical.	83. Faux
84. Le phénotype noir est un facteur de risque pour le développement de l'HTA.	84. Vrai
85. Une diminution de la consommation de sodium <6g/j peut réduire efficacement la pression artérielle.	85. Vrai

86. L'HTA est souvent asymptomatique jusqu'à ce qu'elle atteigne les organes cibles.	86. Vrai
87. Pour mesurer la PA, il est recommandé d'attendre au moins 15 minutes après la consommation de café.	87. Faux
88. Il est préférable que le patient parle pendant la mesure de la PA pour détendre les muscles.	88. Faux
89. Un brassard trop petit surestime la mesure de la pression artérielle.	89. Vrai
90. Lors de la mesure de la PA, la disparition des bruits correspond à la PAS.	90. Faux
91. L'élévation de la PA doit être confirmée par des mesures répétées avant de décider d'un traitement.	91. Vrai
92. Les contraceptifs oraux peuvent causer une hypertension.	92. Vrai
93. La mesure de la tension se fait sur le bras pendant pour éviter toute contraction musculaire.	93. Faux
94. Un taux de potassium inférieur à 3.5 meq/l sans diurétiques peut indiquer un hyperaldostéronisme.	94. Vrai
95. L'hypertension « de la blouse blanche » est une cause de variabilité majeure des chiffres tensionnels.	95. Vrai
96. Le phéochromocytome est une cause fréquente d'HTA qui se manifeste par des palpitations, des céphalées, une transpiration profuse, une HTA labile et une hypotension orthostatique.	96. Faux
97. Les patients atteints de coarctation aortique présentent souvent des pouls fémoraux réduits.	97. Vrai
98. L'HTA essentielle est la cause la plus fréquente d'hypertension.	98. Vrai
99. Les corticostéroïdes peuvent entraîner une augmentation de la pression artérielle.	99. Vrai

100.	La prééclampsie est une cause d'HTA chez les femmes enceintes.	100. Vrai
101.	Un taux élevé de HDL est un facteur de risque pour l'HTA.	101. Faux
102.	La réduction du stress peut avoir un impact significatif sur la PA.	102. Vrai
103.	Les personnes souffrant d'apnée du sommeil sont à risque d'HTA.	103. Vrai
104.	L'hyperparathyroïdie peut provoquer une HTA.	104. Vrai
105.	Le traitement de l'HTA est basé sur le risque de décès cardiovasculaire à court terme.	105. Faux
106.	Le bénéfice du traitement de l'HTA est plus important après une longue période de traitement.	106. Vrai
107.	Les objectifs tensionnels recommandés sont < 130/80 mmHg.	107. Faux
108.	Dans certains cas, un traitement pharmacologique doit être envisagé dès le diagnostic d'HTA.	108. Vrai
109.	Il vaut mieux prescrire un traitement combiné chez les patients de plus de 80 ans ou fragiles.	109. Faux
110.	Les médicaments à prise unique efficaces durant 24 heures sont préférables.	110. Vrai
111.	En cas d'HTA de grade 1, il est recommandé de commencer par une bithérapie.	111. Faux
112.	Le traitement doit être adapté si la réponse hypotensive est insuffisante après 2 semaines.	112. Faux
113.	L'utilisation de diurétiques est recommandée chez les patients âgés.	113. Vrai
114.	Les bêta-bloquants sont contre-indiqués chez les patients souffrant d'asthme et de BPCO.	114. Vrai

115. Les antagonistes calciques sont déconseillés chez les patients atteints de décompensation cardiaque.	115. Vrai
116. Les antagonistes de l'angiotensine II et les sartans sont contre-indiqués chez les patients souffrant de néphropathie diabétique.	116. Faux
117. Les vasodilatateurs directs sont recommandés en cas de résistance aux autres classes thérapeutiques.	117. Vrai
118. L'augmentation de la consommation de potassium peut réduire la tension artérielle.	118. Vrai
119. Un traitement combiné est recommandé dès le début du traitement pharmacologique.	119. Vrai
120. Les antagonistes de l'angiotensine II sont prescrits en cas d'intolérance aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion.	120. Vrai
121. Les diurétiques thiazidiques sont recommandés en cas d'hypertension systolique isolée.	121. Vrai
122. L'hyperkaliémie n'est pas une contre-indication à la prise d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion.	122. Faux
123. Les antagonistes de l'angiotensine II peuvent être associés aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion.	123. Faux
124. Les patients hypertendus doivent éviter les activités physiques intenses.	124. Faux
125. Les diurétiques de l'anse sont des médicaments de choix en cas de décompensation cardiaque.	125. Vrai
126. Les antagonistes calciques sont contre-indiqués chez les patients souffrant de bloc auriculo-ventriculaire.	126. Vrai
127. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont recommandés en cas de dysfonction ventriculaire gauche.	127. Vrai

128.	Les antagonistes calciques sont prescrits en cas d'hypertension diastolique isolée pour réduire la précharge.	128. Faux
129.	Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent être prescrits post-infarctus myocardique.	129. Vrai
130.	Les bêta-bloquants sont évités chez les athlètes car ils peuvent réduire les performances dynamiques.	130. Vrai
131.	Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont recommandés en cas de néphropathie diabétique.	131. Vrai
132.	Les médicaments qui agissent sur le SRAA sont tératogènes.	132. Vrai
133.	Les antagonistes calciques sont recommandés en cas de bloc auriculo-ventriculaire.	133. Faux
134.	La vasoconstriction artériolaire protège les organes en maintenant une perfusion constante pour des élévations modérées de PA.	134. Vrai
135.	L'auto-régulation artériolaire normale se met en place en cas d'élévation très importantes de la PA.	135. Faux
136.	L'hypertension maligne entraîne généralement une perfusion des organes proportionnelle à la PA, ce qui entraîne des lésions endothéliales et une oblitération/nécrose fibrinoïde artériolaire.	136. Vrai
137.	L'HTA maligne se caractérise par un œdème cérébral avec une barrière hémato-méningée intacte.	137. Faux
138.	Les céphalées sont le symptôme le plus fréquent de l'HTA maligne.	138. Faux
139.	Les nausées, les vomissements et les convulsions sont des signes courants d'encéphalopathie hypertensive.	139. Vrai
140.	Le traitement de l'hypertension maligne nécessite généralement une intervention chirurgicale.	140. Faux

141. L'hypertension maligne est souvent traitée avec des médicaments oraux.	141. Faux
142. La tension artérielle ne constitue un risque cardiovasculaire qu'à partir de 140/90mmHg.	142. Faux
143. Le débit cardiaque est déterminée par le produit de la PA et de la résistance vasculaire périphérique.	143. Faux
144. L'activation orthosympathique a tendance à régresser chez le sujet âgé.	144. Vrai
145. Les médicaments qui agissent sur le SRAA améliorent la fonction rénale en cas d'HTA rénovasculaire.	145. Faux
146. On note une histoire familiale chez la majorité des patients atteints de dysplasie fibromusculaire.	146. Faux
147. Les évènements coronaires sont la 1 ^{ère} cause de décès en cas d'HTA.	147. Vrai
148. Il y a une relation constante entre la PA et le risque cardiovasculaire donc le seuil d'HTA est défini selon la balance cout-bénéfice du traitement.	148. Vrai
149. Une pression artérielle à 135-85 correspond à une HTA de grade 1.	149. Faux
150. Le traitement médical est souvent insuffisant et ne normalise pas les chiffres tensionnels.	150. Vrai
151. Les facteurs psychosociaux favorisent l'HTA indépendamment des autres facteurs.	151. Vrai
152. Une hypertension à 170-100mmHg correspond à une HTA de grade 3.	152. Faux
153. L'HTA est la 2 ^{ème} cause d'insuffisance rénale après le diabète.	153. Vrai
154. L'HTA non traitée peut entrainer une insuffisance cardiaque par augmentation de la précharge.	154. Faux

155. Le trou auscultatoire correspond à une disparition transitoire des bruits de Korotkoff lors de la mesure de tension du sujet jeune.	155. Faux
156. La prise de tension doit se faire après au moins 5 minutes de repos et au moins 30 minutes après la consommation de cigarettes.	156. Vrai
157. L'hypotension orthostatique est plus rare chez les patients Parkinsoniens.	157. Faux
158. Les immunosuppresseurs comme le tacrolimus ou la ciclosporine sont une cause d'HTA médicamenteuse.	158. Vrai
159. Une kaliémie $<3,5\text{mEq/L}$ ne fait pas penser à un hyperaldostéronisme si le patient est sous diurétiques.	159. Vrai
160. L'HTA est un effet secondaire des inhibiteurs de la monoamine oxydase.	160. Vrai
161. On associe des antagonistes calciques et des diurétiques dès le début du traitement anti-hypertenseur.	161. Faux
162. La spironolactone est ajoutée à la trithérapie en cas d'HTA résistante.	162. Vrai